

ESCALA DE AGITACIÓN Y SEDACIÓN DE RICHMOND (RASS)

Titulación Dirigida de la Sedación y Agitación en Cuidados Críticos

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

DIEZ NIVELES DE AGITACIÓN Y SEDACIÓN

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
+4: Combativo/a Conducta violenta	☐ Completamente combativo/a o violento/a; peligro inmediato para la seguridad del personal. (4)	[]
+3: Muy Agitado/a Conducta agresiva	☐ Se retira o se quita tubos o catéteres; agresivo/a. (3)	[]
+2: Agitado/a Movimiento no intencionado	☐ Movimientos no intencionados frecuentes o asincronía paciente-ventilador. (2)	[]
+1: Inquieto/a Ansioso/a	☐ Ansioso/a o aprensivo/a pero los movimientos no son agresivos ni vigorosos. (1)	[]
0: Alerta y Tranquilo/a Estado basal objetivo	☐ Espontáneamente alerta, tranquilo/a, presta atención al examinador. (0)	[]
-1: Somnoliento/a Sedación leve	☐ No está plenamente alerta, pero mantiene el despertar (contacto visual a la voz ≥ 10s). (-1)	[]
-2: Sedación Leve Contacto visual breve	☐ Se despierta brevemente con contacto visual a la voz (< 10 segundos). (-2)	[]
-3: Sedación Moderada Movimiento a la voz	☐ Cualquier movimiento (apertura ocular o extremidades) a la voz, pero sin contacto visual. (-3)	[]
-4: Sedación Profunda Estímulo físico sólo	☐ Sin respuesta a la voz, pero algún movimiento al estímulo físico (sacudida de hombro). (-4)	[]
-5: Inconsciente / Arreactivo Sin respuesta al dolor	☐ Sin respuesta a la voz ni al estímulo físico (frotamiento externo / presión ungüeal). (-5)	[]

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 10 niveles (-5 a +4))

Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°): _____

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Estado Agitado (+1 a +4)
(+1 a +4)

Evaluar dolor (BPS/CPOT), evaluar delirium (CAM-ICU), tratar causa desencadenante.

Sedación Objetivo (0 a -1)
(0 a -1)

Objetivo ideal para la mayoría de pacientes despiertos y ventilados en UCI.

Sedación Moderada (-2 a -3)
(-2 a -3)

Objetivo en asincronía severa con ventilador o decúbito prono.

Sedación Profunda (-4 a -5)
(-4 a -5)

Realizar prueba de despertar espontáneo (SAT) diaria salvo contraindicación.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación